Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Balcão Virtual (55)99913-2599 - Email: fruruguaia2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005806-52.2023.8.21.0037/RS

AUTOR: QUELEN ANDREIA DE OLIVEIRA MILITAO
ADVOGADO(A): DANIEL CHARAO (OAB RS108715)

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

QUELEN ANDREIA DE OLIVEIRA MILITAO ajuizou ação para fornecimento de medicamento em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ambos qualificados na inicial (evento 1, INIC1). Inicialmente, falou sobre a prioridade de tramitação e necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Disse que é portadora de neoplasia, câncer de mama, CID C50.8, desde o ano de 2019. Aduziu que, diante da gravidade da doença, submeteu-se a cirurgia e a tratamento com quimioterapia adjuvante. Mencionou que, por 05 anos, foi utilizado o protocolo AC/P (*doxorrubicina, ciclofosfamida* e *paclitaxel*), radioterapia adjuvante e *tamoxifeno* adjuvante. Referiu que seu quadro de agravou, evoluindo para metástases ósseas no ano de 2021, razão pela qual foi necessário receber tratamento de primeira linha com os fármacos *tamoxifeno* e *palblocliede*, no período compreendido entre maio e dezembro de 2021. Disse que a doença progrediu e, então, em janeiro de 2022, passou a realizar tratamento utilizando os medicamentos *letrozol* e *ribociclibe*. Aduziu que, em outubro de 2022, exames demonstraram nova progressão da doença, sendo necessária, então, uma terceira linha de tratamento, com a utilização dos medicamentos *abemaciclibe* e *fulvestranto*. Afirmou que lhe foi indicado tratamento com a utilização do remédio *abemaciclibe*, na dose de 150mg, 1 comprimido de 12/12h, de uso contínuo. Referiu que 02 comprimidos diários custam o montante de R$ 423,80, de modo que o tratamento atinge a quantia de R$ 154.687,00 por ano. Aduziu que o medicamento não é fornecido pelo SUS - Sistema Único de Saúde. Esclareceu que o não uso da medicação ou o atraso no início do tratamento ensejará risco de progressão da doença, com envolvimento em outros órgãos vitais e até possível óbito. Asseverou que a utilização do fármaco é necessária à medida que não existem outros remédios que podem substituí-lo sem causar prejuízos irreparáveis à demandante. Indicou a existência de laudo médico que informa a necessidade urgente e indispensável de utilização do medicamento *abemaciclibe.* Asseverou que não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento anual, que atinge a soma de R$ 154.687,00. Repisou que o medicamento não consta na lista para distribuição pelo SUS, razão pela qual não obteve êxito em recebê-lo através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Aduziu que, segundo a médica que lhe acompanha, não há outra medicação disponível pelo sistema público que substitua o medicamento prescrito com igual benefício clínico e ganho de sobrevida e qualidade de vida. Falou sobre a legitimidade passiva do ESTADO. Mencionou que o medicamento encontra-se registrado na ANVISA. Defendeu que preenche os requisitos exigidos pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e, c) existência de registro do medicamento na ANVISA. Requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento *abemaciclibe,* na dose de 150mg, 01 comprimido de 12/12h, sendo 60 comprimidos ao mês, de forma gratuita, contínua e por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio de valores. Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento. Pugnou pela concessão do benefício de gratuidade de justiça e requereu a tramitação preferencial. Juntou documentos no E1.

Na decisão do evento 3, DESPADEC1, deferiu-se o benefício da gratuidade de justiça à autora, assim como o pedido de tutela de urgência, determinando-se ao ESTADO o fornecimento da medicação *abemaciclibe* 150mg, um comprimido a cada 12 horas, por tempo indeterminado (quantidade necessária ao primeiro ciclo do tratamento, conforme exposto na inicial) ou seu equivalente, desde que observado o mesmo princípio ativo. Na hipótese de descumprimento, autorizou-se o bloqueio de valores diretamente na conta do demandado.

Citado e intimado (E10), o réu interpôs agravo de instrumento (E11), autuado sob o n° **5168329-74.2023.8.21.7000/TJRS**, que foi parcialmente provido, para o fim de determinar a emenda da inicial, com a inclusão da UNIÃO no polo passivo da lide, mantendo a tutela de urgência antes deferida (processo 5168329-74.2023.8.21.7000/TJRS, evento 6, DECMONO1).

A autora apresentou emenda à inicial (evento 14, EMENDAINIC1), requerendo a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da lide e, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal.

A emenda da inicial foi acolhida, determinando-se a inclusão da UNIÃO no polo passivo da lide e, assim, declinando da competência para processamento e julgamento do feito à Justiça Federal (evento 16, DESPADEC1).

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 23, CONT1). Inicialmente, falou sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo, em atenção ao que foi decidido em 19/04/2023 pelo STF na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (*Leading Case* do Tema 1.234), bem como levando em conta que o tratamento oncológico postulado é custeado por recursos federais no âmbito do SUS. Sustentou a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, inclusive conforme já decidido em sede de agravo de instrumento. Discorreu sobre o custeio de tratamento oncológico, afirmando que é da UNIÃO a responsabilidade pela organização e financiamento de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS. Discorreu, também, sobre a política nacional de prevenção e controle do câncer;

sobre a distribuição de competências entre União, Estados, CACONs e UNACONs para o fornecimento de tratamentos oncológicos pelo SUS, especialmente sobre distribuição de verbas; bem como sobre a necessidade de obediência ao decidido pelo STF no julgamento do TEMA 793. Falou acerca do cumprimento de sentença e ressarcimento em caso de bloqueio de valores, bem como acerca da fixação de honorários advocatícios. Ao final, requereu a remessa dos autos ao juízo federal e, no mérito, a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requereu seja expressamente reconhecido que o custeio do tratamento oncológico é de responsabilidade da UNIÃO, devendo ser financiado com recursos federais, ressarcindo-se o ESTADO em caso de sequestro de valores. Requereu a intimação da autora para juntada de documentos. Juntou documento.

O feito foi remetido à Justiça Federal (E24 e E25).

Em decisão proferida perante o juízo federal (evento 33, DESPADEC1), reconheceu-se que, em se tratando de ação tem por objeto o fornecimento de medicamento oncológico, era caso de competência da Justiça Federal. Deferiu-se gratuidade de justiça à autora e determinou-se sua intimação para juntada de documentos. Determinou-se, ainda, fosse realizada avaliação técnica pelo TelessaúdeRS**,** na condição de NAT-jus/JFRS, a título de perícia indireta. Caso a nota técnica for considerada insuficiente, determinou-se a intimação da parte ré para esclarecer se a tecnologia já foi analisada pela CONITEC e, em caso positivo, qual foi o resultado e onde pode ser encontrado, bem como se há substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS e quais são. Fixou-se que, após atendidas tais determinações, voltassem os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.

A requerente manifestou-se no evento 44, OUT1, respondendo aos questionamentos do juízo e juntando documentos.

No evento 47, NOTATEC1, aportou a nota técnica oriunda do Núcleo de Apoio Técnico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (NAT-Jus/JFRS).

A UNIÃO opôs embargos de declaração (evento 52, EMBDECL1), alegando a existência de omissão na decisão proferida pelo juízo federal. Sustentou que, em se tratando de demanda por medicamento não padronizado na política pública, ajuizada originalmente na Justiça Estadual, com determinação posterior de inclusão da União no polo passivo, por força das decisões proferidas pelo STJ e STF, deve a União ser excluída do polo passivo, com a devolução dos autos ao juízo de origem. Juntou documento.

Na sequência, a UNIÃO se manifestou sobre a nota técnica (evento 54, PET1), requerendo a improcedência da ação.

A requerente também se manifestou sobre a nota técnica (evento 57, PET2) e juntou laudo médico.

Os embargos declaratórios opostos pela UNIÃO não foram conhecidos, pois intempestivos (evento 58, DESPADEC1).

A demandante manifestou-se e juntou laudo médico (E61).

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL manifestou-se sobre a nota técnica (evento 62, PET1), postulando seu acolhimento para o fim de ilidir a pretensão da autora quanto ao fornecimento do medicamento *abemaciclibe.*

No evento 63, PET1, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ratificou os termos da contestação antes apresentada e arguiu que o parecer exarado pelo Núcleo TelessaúdeRS posicionou-se contrariamente ao pedido da autora, algo que afirmou reforçar os argumentos da peça defensiva e, assim, a improcedência da ação.

Na decisão do evento 65, DESPADEC1, deferiu-se o pedido de tutela de urgência, para determinar aos réus o fornecimento do medicamento *abemaciclibe* 150mg, no prazo de 15 dias, diretamente na UNACON em que a autora realiza seu tratamento. Fixou-se, ainda, sobre a necessidade de eventual custeio financeiro do medicamento, em caso de não fornecimento.

A UNIÃO apresentou contestação (evento 74, CONT1) arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo federal. Aduziu que o fármaco objeto da lide consiste em medicamento não padronizado na política pública, tendo o feito sido originalmente distribuído à justiça comum, com posterior determinação de inclusão da UNIÃO no polo passivo, sem que, até o momento, tenha sido proferida sentença. Arguiu que, por força de entendimento exarado pelo STF, necessária sua exclusão do polo passivo e retorno dos autos à Justiça Estadual. No mérito, alegou que a conclusão da nota técnica foi desfavorável ao fornecimento do medicamento. Discorreu sobre o fornecimento de medicamentos em assistência oncológica. Sustentou a necessidade de tratamento no âmbito do CACON/UNACON, argumentando que se o paciente quer receber o tratamento de câncer pelo SUS, deve se submeter à política pública oncológica, sob pena de estar auferino privilégio vedado pelo art. 7°, VII da Lei n° 8.080/90. Falou sobre a incorporação de novas tecnologias pelo SUS, aduzindo que se faz necessária a comprovação de evidências científicas e avaliação econômica comparativa dos custos e benefícios. Defendeu ser imprescindível a análise dos protocolos e decisões da CONITEC. Sustentou a necessidade de produção de prova pericial. Discorreu sobre o processamento na hipótese de procedência. Ao final, requereu o reconhecimento de incompetência do juízo, com a restituição dos autos à Justiça Comum. Requereu a improcedência da ação e formulou pedidos para o caso de procedência.

Aportou nova manifestação da UNIÃO (evento 80, PET1), requerendo sua exclusão do polo passivo e devolução dos autos à Justiça Comum. Juntou documento.

Foi mantido o deferimento da tutela de urgência (evento 89, DESPADEC1).

A UNIÃO informou a interposição de agravo de instrumento (evento 95, PET1), ao qual foi atribuído efeito suspensivo (evento 99, DESPADEC1).

Na decisão do evento 100, DESPADEC1, determinou-se a exclusão da UNIÃO do polo passivo da lide e o retorno dos autos a este juízo.

O feito foi reativado (E105).

Os atos praticados no juízo federal foram ratificados (evento 107, DESPADEC1).

Intimados sobre o interesse na produção de outras provas, o ESTADO manifestou-se no evento 111, PET1, postulando a intimação da autora nos moldes do pleito formulado no item f da contestação (evento 23, CONT1). A requerente, de seu lado, manifestou desinteresse na produção de provas (evento 113, PET1).

No evento 115, DESPADEC1, deferiu-se o pedido formulado pelo ESTADO, intimando-se a parte autora para prestar esclarecimentos, o que foi atendido no evento 119, PET1, ocasião em que a autora, ainda, juntou documento.

Intimado (evento 123, DESPADEC1), o requerido nada opôs quanto à manifestação da requerente (evento 129, PET1).

O Ministério Público deixou de externar parecer (evento 139, PARECER1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação por meio da qual a requerente pretende a condenação do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao fornecimento do medicamento *abemaciclibe,* na dose de 150mg, 01 comprimido de 12/12h, sendo 60 comprimidos ao mês, de forma gratuita, contínua e por tempo indeterminado, para o tratamento da doença que lhe acomete, consistente em neoplasia, câncer de mama, CID C50.8, desde o ano de 2019, que evoluiu para metástases ósseas no ano de 2021.

Inicialmente, esclareço que as questões relacionadas a competência e necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da lide já foram analisadas, sendo fixada a competência deste juízo para apreciação do feito, com a manuteção apenas do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no polo passivo da lide, nos termos da decisão proferida no evento 99, DESPADEC1.

Ademais, no que concerne à competência fixada pelo **TEMA 1234 do STF**, destaca-se ter ficado estabelecido que a inclusão da UNIÃO no polo passivo deve ser analisada conforme a data de ajuizamento da ação, a fim de se modular os efeitos da decisão paradigma do STF, para se definir a competência, mantendo-se inalterada a competência das ações distribuídas até a data de publicação do resultado do julgamento do mérito do RE 1366243.

Conforme ementada do SEXTOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 SANTA CATARINA[1]:

> *(...) 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234,* ***quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).***

No caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 24/05/2023, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento, afasta-se a necessidade de inclusão da UNIÃO, no que diz respeito ao TEMA 1234 do STF, tal qual, inclusive, já decidido na decisão do evento 99, DESPADEC1, antes mencionada.

Nesse sentido:

> ***Ementa:*** *PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA Nº 1.234, STF). INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. Ajuizada a ação em 11.07.2022, anteriormente à publicação do julgamento do mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234) pelo Plenário do STF, não se aplicam, ao caso, as definições da Corte Suprema no que tange à competência para processamento e julgamento das demandas em que pleiteada condenação do Estado, lato sensu considerado, ao fornecimento de medicamento, tendo em vista a modulação dos efeitos da referida decisão, não sendo caso, pois, de juízo de retratação, mantendo-se o acórdão ora reapreciado. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Agravo de Instrumento, Nº 51427263320228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 08-05-2025)*

Dito isso, ainda de início, cumpre mencionar que o fármaco objeto da lide, *abemaciclibe,* consiste em medicamento com registro na ANVISA e, apesar de não constar no RENAME 2022, foi incorporado à politica do SUS para tratamento oncológico, conforme expresso no art. 1º da **Portaria nº 73/21** da Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde, para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Ainda sobre a incorporação do medicamento *abemaciclibe* pelo SUS, colaciono os seguintes julgados:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento oncológico "abemaciclibe", necessário ao tratamento de carcinoma de mama metastático da parte autora, sob risco de rápida progressão da doença e óbito. II. Razões de decidir: Comprovada a necessidade do medicamento mediante prescrição médica e relatada a urgência em virtude da gravidade do quadro clínico, configura-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que, em casos*

de comprovada urgência e necessidade médica, deve ser garantido o tratamento ainda que não previsto nos protocolos da entidade de assistência à saúde. O medicamento "abemaciclibe" está incorporado ao SUS para o tratamento de câncer de mama, além de constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. A vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação não se aplica ao caso, por tratar-se de medida reversível e necessária à preservação da saúde e da vida da parte autora. III. Tese de julgamento: 1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico necessário ao tratamento de câncer metastático. 2. A liminar que garante o direito à saúde em caráter de urgência não se confunde com medida satisfativa irreversível vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, quando há possibilidade de reversão e risco à vida. RECURSO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 50425608520258217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 02-05-2025)

Ementa: *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ABEMACICLIBE 150MG. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJRS. ART. 932, VIII, DO CPC. ART. 206, XXXVI, DO RITJRS. A matéria ventilada no presente agravo de instrumento é recorrente, existindo jurisprudência pacífica a respeito no Supremo Tribunal Federal e nesta Egrégia Corte, justificando-se o julgamento monocrático. 2. TEMAS 1234/STF E 06/STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS COM RELAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS PARA A DISPENSAÇÃO DOS FÁRMACOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. O dever de observância de teses fixadas em sede de julgamento repetitivo se encontra expressamente previsto no art. 927, III, do CPC. Conforme jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, o entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral possui aplicabilidade imediata aos processos sem trânsito em julgado, inclusive às ações que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, sendo desnecessário, ademais, o trânsito em julgado do acórdão paradigma. No julgamento dos Temas 06 e 1.234 pelo STF, não houve modulação de efeitos da decisão em relação ao mérito das ações que visam ao fornecimento de medicamentos incorporados, cuja aplicação é imediata. 3. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ONCOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Na hipótese dos autos, o fármaco vindicado pela parte autora foi incorporado no âmbito do SUS por meio da Portaria SCTIE nº 73/2021, do Ministério da Saúde para tratamento da doença que a acomete, razão pela qual, apesar de assistir razão ao recorrente quanto à submissão do caso ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1234, está devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a qual vai mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50888990520258217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 14-04-2025)*

Assim, tem-se que o fármaco objeto da lide (*abemaciclibe*) se trata de medicamento com registro na ANVISA e incorporado pelo SUS.

Feitos tais esclarecimentos, parto ao exame do mérito.

A obrigação no fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre da Constituição Federal.

Sabidamente, o constituinte garantiu de forma expressa no art. 196 "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Outrossim, destaca-se, implícito no art. 5°, *caput*, o direito à vida, bem como estabeleceu em seu artigo 6° o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental, não sendo lícita a supressão dos aludidos direitos, face à proibição de retrocesso.

Ora, a negativa de fornecimento dos medicamentos necessários à saúde e à vida da paciente sem condições econômicas de adquiri-los configura, por si só, supressão de direito fundamental à saúde. Assim, não ocorre qualquer violação à independência do Poder Executivo, na medida em que não se está dispondo acerca de matéria orçamentária na sentença, tão-somente evitando-se a supressão de garantia fundamental.

Dito isso, na hipótese dos autos, a parte autora acostou inúmeros laudos médicos detalhados dando conta da doença que lhe acomete, bem como dos tratamentos já realizados, conforme se verifica do evento 1, OUT10, evento 44, ATESTMED2, evento 57, OUT1 e evento 61, LAUDO2, que demonstram a doença que lhe acomete. Por oportuno, colaciono o laudo que acompanhou a inicial (juntado no evento 1, OUT10), que bem descreveu o quadro clínico da requerente:

Quelen Andreia de Oliveira Militão, 31 anos, portadora de patologia CID 10 – C50.8 – Câncer de Mama desde maio de 2019. Foi submetida à cirurgia, quimioterapia adjuvante com o protocolo AC/P (doxorrubicina, ciclofosfamida e paclitaxel), radioterapia adjuvante e tamoxifeno adjuvante por 5 anos. Evoluiu com metástases ósseas em 2021. Recebeu tratamento de primeira linha com tamoxifeno e palboclibe de maio de 2021 a dezembro de 2021. Após progressão de doença, em janeiro de 2022, tratamento foi mudado para letrozol e ribociclibe, protocolo utilizado de janeiro de 2022 a setembro de 2022. Em outubro de 2022, exames de reestadiamento mostraram nova progressão de doença, iniciando terceira linha de tratamento com abemaciclibe e fulvestranto.

Até o momento, a paciente possuía o convênio Unimed, porém agora está sem convênio e vai seguir seu tratamentoo no Sistema Único de Saúde. As medicações abemaciclibe e fulvestranto não são disponíveis no SUS. O fulvestranto pode ser substituído por anastrozol, porém o abemaciclibe não possui nenhuma medicação que o substitua.

Tendo em vista que a paciente é jovem e possui apenas metástases ósseas, o que não a torna candidata a tratamento quimioterápico; e considerando que a paciente já falhou a hormonioterapia exclusiva, indico manutenção do tratamento abemaciclibe, que será associado ao anastrozol (esse disponível no SUS).

A paciente Quelen Andreia de Oliveira Militão necessita da medicação abemaciclibe com urgência. O não uso da medicação compromete sua qualidade de vida e coloca sua vida em risco de morte.

Estudos que comprovam a eficácia do tratamento solicitado: Estudo MONARCH-3, publicado no J Clin Oncol 35:36,38, 2017 e NPJ Breast Cancer 5:5, 2019.

A receita médica juntada no evento 1, RECEIT11, comprova a prescrição, pela médica que a examinou e acompanha a evolução da doença, do medicamento ora pleiteado.

Da mesma forma, a negativa do Estado no fornecimento do fármaco além de constituir fato público e notório, restou demonstrada através do documento juntado no evento 1, OUT12.

Em acréscimo, evidencia-se, considerando as declarações acostadas no evento 1, DECL8, evento 1, OUT9, evento 44, OUT4, evento 44, OUT5 e evento 119, OUT2, tem-se que demonstrada situação a lhe conferir hipossuficiência financeira à aquisição das medicações.

Portanto, impõe-se o julgamento de procedência do pedido, com a confirmação da liminar, para que o demandado forneça à parte autora o tratamento postulado.

Por fim, cumpre esclarecer que, conforme fixado no TEMA 1234 do STF, em se tratando de ação para fornecimento de medicamento oncológico, ou seja, de competência da UNIÃO, incorporado pelo SUS, é caso de ressarcimento, pela UNIÃO em favor do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, das despesas pelo tratamento, conforme item 6 da tese fixada, que ora segue:

> *6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.*
>
> *6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestálo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.*

Por oportuno, cumpre mencionar que, a respeito de **medicação oncológica**, ficou acertado no Tema 1234 do STF:

> *Por sua vez, citem-se os termos do adendo no que diz respeito aos medicamentos oncológicos:*
>
> *"1.1. Serão consideradas como de competência da Justiça Federal as demandas de medicamentos para tratamento oncológico, cujo valor anual de aquisição de fármaco, por paciente, seja igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salériosmínimos.* ***As demandas de medicamentos para tratamento oncológico cujo custo seja inferior a este valor, serão de competência da Justiça Estadual.*** *- Grifei -*
>
> *CLAUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO*
> *2.1.* ***Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados*** *e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado.*
> *2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo. Grifei!*
>
> *(...)*
>
> ***III. CUSTEIO***
>
> *(...)*
>
> *3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento* ***oncológico****,* ***as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024*** *serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. - Grifei -*
>
> *(...)".*

No mesmo sentido, ainda:

> ***Ementa:*** *DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ABIRATERONA PARA CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE ÓSSEA. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE NÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente ação com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg à parte autora, diagnosticada com câncer de próstata com metástase óssea (CID10 C61). O ente recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual, com base na tese firmada no Tema 793 do STF, por se tratar de medicamento oncológico incorporado ao SUS, cuja responsabilidade seria da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da União a competência para responder pela demanda de fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da responsabilidade não solidária do ente estadual, com direito ao ressarcimento pela União, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS se insere na obrigação solidária dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em incompetência da Justiça Estadual quando apenas um ente é demandado. 4. O Tema 1234 do STF, que trata da responsabilidade financeira pelo custeio de medicamentos, estabelece que, em caso de fornecimento de medicamento integrante de política pública nacional, deve-se reconhecer a responsabilidade não solidária do ente federativo e assegurar o ressarcimento pela União ao ente executor.* ***5. Assim, embora se mantenha a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao fornecimento do fármaco, é devida a aplicação do Tema 1234 do STF para reconhecer sua responsabilidade não solidária e assegurar, de ofício, o ressarcimento de valores pela União, via mecanismo Fundo a Fund****o. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento, ainda que incorporado ao SUS e de uso oncológico, quando a União não é parte no polo passivo. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS por ente estadual não configura responsabilidade solidária, sendo aplicável a tese do Tema 1234 do STF para fins de ressarcimento pela União, via repasse Fundo a Fundo. A modulação dos efeitos da tese do Tema 1234 do STF impõe o reconhecimento da responsabilidade não solidária do ente estadual, assegurando-se o direito ao ressarcimento dos valores pela União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.05.2016; STF, RE 1366240 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.03.2024. (Recurso Inominado, Nº 50190015320228210033, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 22-05-2025)*

Assim, é hipótese de determinar a aplicação do TEMA 1234 do STF relacionado ao custeio da medicação, para, especificamente, assegurar o ressarcimento de valores pela União, na forma prevista no precedente vinculante, se for o caso.

No tocante ao arbitramento dos honorários, considerando que se trata de ação que envolve direito à saúde, matéria cuja natureza não é de grande complexidade, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (**TEMA 1076**), firmou a seguinte tese:

> *i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.*
>
> *ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.*

Com efeito, no caso em apreço, considerando o alto valor atribuído à causa e sua baixa complexidade, desproporcional a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, devendo esta ser feita de forma equitativa porquanto inestimável o proveito econômico da demanda, já que se trata de ação na qual o pleito é, em suma, o fornecimento de tratamento médico e a garantia do direito à vida e à saúde da parte autora.

Pelo exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por **QUELEN ANDREIA DE OLIVEIRA MILITAO** em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para, confirmando as tutelas de urgência anteriormente deferidas, determinar ao requerido que forneça à requerente o fármaco *abemaciclibe*, na dose de 150mg, 01 comprimido de 12/12h, sendo 60 comprimidos ao mês, de forma gratuita, contínua e por tempo indeterminado, ou providencie a liberação do valor correspondente. Tal obrigação fica condicionada à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada 6 meses. Eventual descumprimento acarretará o bloqueio das quantias correspondentes.

Isento o **ESTADO** do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Por outro lado, conforme fundamentação supra, condeno o **ESTADO** ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia de R$ 1.500,00, ora fixados levando em conta os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2°e 8° do Código de Processo Civil. O valor deverá atualizado unicamente pela taxa *selic*, em atenção à implementação imposta pela Emenda Constitucional n° 113/2021, a partir da presente decisão.

Publicação e registro eletrônicos. Agendada a intimação das partes pelo sistema.

Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, no prazo legal, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, cumpridas as determinações finais da sentença passíveis de cumprimento *ex officio* e, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **KARINA DE OLIVEIRA LEONETTI PADILHA, Juíza de Direito**, em 02/07/2025, às 17:31:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10085666715v28** e o código CRC **d6ab3dcb**.

---

1. portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939 ↩